



QUAND L'INFORMATION GÉNÉTIQUE DÉPASSE LE RÉSULTAT BIOLOGIQUE : CONSÉQUENCES PSYCHOSOCIALES DE L'ANNONCE DU STATUT DE PORTEUR HÉTÉROZYGOTE D'UNE HÉMOGLOBINOPATHIE

Kehila. S^{1,2} ; Boulemkahel. NH¹ ; Bounaas. S^{1,2} ; Lasgaa. R¹ ; Djerdi. R¹

1. Laboratoire central de biologie médicale, CHU Sétif

2. Faculté de médecine, Université Ferhat Abbas 01 Sétif

Introduction

Les hémoglobinopathies constituent un groupe d'affections génétiques nécessitant une approche intégrée associant diagnostic biologique, dépistage familial et conseil génétique. L'identification d'un statut de porteur hétérozygote représente une information essentielle dans l'évaluation du risque de transmission. Cependant, lorsque les mécanismes d'hérédité sont mal compris, cette information peut être interprétée de manière erronée et entraîner des conséquences psychosociales inattendues.

Objectif : décrire les conséquences psychosociales associées à l'annonce du statut de porteur hétérozygote d'une hémoglobinopathie et analyser les difficultés rencontrées par le biologiste médical dans la communication des résultats.

Matériel et méthodes

Une étude observationnelle descriptive a été menée au sein de l'Unité d'Hémobiologie du Laboratoire Central du CHU de Sétif sur une période de 15 mois . Les observations ont été recueillies au cours de l'activité quotidienne du laboratoire lors de la restitution des résultats d'exploration des hémoglobinopathies. Ont été incluses les situations ayant nécessité un accompagnement spécifique en raison d'une **incompréhension** du statut de porteur, d'un refus des explications concernant la transmission génétique ou de répercussions familiales rapportées.

Résultats

Au total, 42 situations familiales ont été observées, dont 28 (66,7 %) ont nécessité un conseil génétique approfondi. Dans 9 cas (21,4 %), le statut hétérozygote a été interprété à tort comme une responsabilité directe de la mère dans la maladie de l'enfant. Malgré des explications répétées concernant les mécanismes de transmission génétique, un refus d'adhésion aux informations médicales fournies par le conjoint a été observé dans 7 cas (16,7 %). Les conséquences psychosociales rapportées comprenaient une culpabilisation maternelle dans 9 cas (21,4 %), des conflits conjugaux dans 6 cas (14,3 %), une remise en question de la responsabilité parentale dans 1 cas (2,3 %) et des situations de souffrance psychologique rapportées par les patientes dans 3 cas (7,1 %).

Discussion

•Le statut hétérozygote, bien qu'il corresponde généralement à un état de portage sain, peut être associé à des répercussions psychosociales importantes. Les incompréhensions peuvent favoriser la **culpabilisation maternelle, les tensions conjugales, la remise en question de la responsabilité parentale et une souffrance psychologique**.

•Les interprétations erronées du statut de porteur traduisent une compréhension insuffisante des mécanismes de transmission héréditaire. La confusion entre **portage hétérozygote et expression de la maladie** peut conduire à attribuer injustement la responsabilité de la maladie à l'un des parents, notamment à la mère.

•**Le niveau socioculturel et la littératie en santé** peuvent influencer l'accès à l'information médicale, la compréhension du vocabulaire génétique et l'adhésion aux explications délivrées. Ces facteurs doivent donc être pris en compte lors de l'annonce et de l'interprétation des résultats.

•**Le conseil génétique** constitue un élément essentiel pour expliquer le mode de transmission, le risque reproductif et la signification du statut hétérozygote. Une information **claire, progressive et adaptée au niveau de compréhension de chaque famille** permet de corriger les représentations erronées et de réduire la culpabilisation.

•L'implication des deux parents dans le processus d'information favorise une compréhension commune du risque génétique et limite les interprétations accusatoires. Une **approche familiale et multidisciplinaire** permet ainsi de mieux prévenir les conséquences psychosociales associées au diagnostic.

•Ces données soulignent l'importance d'une **approche multidimensionnelle** intégrant les aspects biologiques, éducatifs et psychosociaux afin de réduire l'impact familial du diagnostic des hémoglobinopathies.

Conclusion

Cette étude souligne que l'annonce d'un résultat génétique constitue un acte médical complexe dépassant la seule dimension analytique. Une communication adaptée et un conseil génétique structuré sont indispensables pour prévenir les interprétations erronées, la stigmatisation des porteurs et leurs conséquences psychosociales.